

- 13★★★
☑☑☑ 喀痰中 IL-6 の濃度が上昇している。
- 14★★★
☑☑☑ Toll 様受容体 4 (TLR4) は気道炎症の惹起に寄与する。
- 15★★★
☑☑☑ IL-33 やグループ 2 自然リンパ球 (ILC2) の浸潤が特徴である。
- 16★★★
☑☑☑ 重症例ではインフリキシマブの投与により、症状および呼吸機能の改善が示されている。
- 17★★★
☑☑☑ プロテアーゼとアンチプロテアーゼの均衡が崩れ、アンチプロテアーゼ優位に傾いている。
- 18★★★
☑☑☑ マトリックスメタロプロテイナーゼ (MMP) の活性化により、肺気腫の形成は促進される。
- 19★★★
☑☑☑ 喀痰中好中球エラスターゼは減少する。
- 20★★★
☑☑☑ 発症には過剰な酸化ストレスが関与する。
- 21★★★
☑☑☑ 気管支粘膜下腺の増大と杯細胞の増生を認める。
- 22★★★
☑☑☑ 肺動脈では内膜や血管平滑筋の肥厚、炎症細胞の浸潤、壁の線維化がみられる。
- 23★★★
☑☑☑ 肺組織では Tc1 型 CD8⁺T リンパ球の浸潤が特徴である。
- 24★★★
☑☑☑ Th2 型 CD4⁺T 細胞の浸潤が目立つ例では、喘息合併の可能性を考慮する必要がある。
- 25★★★
☑☑☑ 禁煙後は数日以内に気道炎症が改善する。
- 26★★★
☑☑☑ 妊娠時の母体の喫煙は、COPD 発症のリスク因子である。
- 27★★★
☑☑☑ 幼少期の重症呼吸器感染は、COPD 発症のリスク因子である。